救護演練室

EMT-1 主副手情境考試
嚴格版精華講義

11 個老師指定情境 + OHCA | 依課程照片、消防署與 AHA 整理 | 2026-11-07

使用順序

先讀共同流程和跳轉條件，再讀自己今天要練的情境頁。兩人輪流主手、副手，邊講邊做；搭檔逐項對照，最後用網站回放找漏項。

本班已確認的考核

項目	照片上的規則
平時測驗	50 分；第 2–6 天，每次 10 分，共 5 次
OHCA 流程	25 分；至少 19 分
情境測驗	25 分；至少 19 分
技術總成績	三項合計至少 76 分，OHCA 與情境不得低於 19 分

如何看待「嚴格」

OHCA 依你提供的評分表對照；其他情境沒有正式評分表，使用教材與公開官方指引建立必要流程檢核。其他機構的考規列在附錄，不冒充你這班的規則。單站正式時限未查到，網站倒數僅供自訂壓力練習。

數位演練的邊界

網站能練操作選擇、主副手占手、指令、並行工作、病況變化與流程切換。按壓位置、深度、回彈、BVM 密合與真實胸起必須用假人、QCPR 及教官評核。本講義不保證通過考試。

先記住這一張路線圖

現場：安全 → 個人防護 → 人數、檢傷與 119 → 接近患者 / 器材就位。創傷同步頸椎保護，致命出血立即處理。

初評：意識 → A 呼吸道 → B 呼吸 → C 循環；創傷用 XABCDE，X 大出血，D 神經，E 暴露。發現致命問題，當下處理。

危急判斷 → 快速後送準備與必要處置並行 → 二度評估（八大徵象、病史、身體檢查）→ 持續重評 / 通報。不能為背完整套而拖延救命處置。

會直接跳流程的 5 個地方

① 無反應 + 無正常呼吸 / 僅瀕死喘息 + 10 秒內無確定脈搏：跳 OHCA，CPR 30:2 + AED。

② 有脈搏 + 呼吸不足 / 停止：跳呼吸支持，BVM 每 6 秒一口，約每 2 分鐘重評脈搏；失去脈搏才轉 CPR。

③ 致命外出血：在 X 先止血，再接續評估。另一位可同步做 ABC。

④ 任何時刻患者惡化：立即回 ABC / 呼吸脈搏，不等待原本檢查做完。

⑤ AED 不建議電擊不代表 ROSC。第一輪立即 CPR；依課程後續重評脈搏，有脈搏後再分正常呼吸或人工呼吸。

主手、副手如何分工

主手通常負責：現場判斷、患者意識與 ABC / XABCDE、危急辨識、主要指令、按壓或評估。副手通常負責：器材、氧氣 / BVM、AED、量測、病史、通報與後送準備。

分工依當下手是否被占用調整。任何人持續手持頸椎、直接加壓或 BVM 密合時，不能同時去拿器材或做別的操作。

交接三句：「我要接手。」「我已接穩 / 接好。」「好，我放手。」先接後放；一人下明確指令，另一人回報完成與數值。

兩分鐘左右可交換按壓者；AED 語音與危急處置優先，減少按壓中斷。

共同流程：主副手對照

階段	主手	副手
現場	確認安全、人數、檢傷、求援	完成防護、器材就位；創傷依需求接手減移
初評	意識、ABC / XABCDE、發現威脅立即處理	按指令準備氧氣、BVM、AED、止血或固定器材
危急	說出危急原因、請求支援、下明確指令	量測與回報；準備快速後送
二評	神經、身體檢查、情境專屬檢查	病史、血糖、12 導程等；不延誤救命處置
重評 / 交接	病況變化回 ABC，確認處置效果	通報病人要史已前到，照護與處置不中斷

口令範本

主手：「副手，請量血壓、血氧並回報。」副手：「收到。血壓 86 / 50，血氧 89%。」
主手：「危急，請求進階支援，準備後送。我持續加壓，你準備止血帶。」
交接：「我準備接手。」「我已接穩。」「好，我放手。」

先背這些數字與口訣

成人 CPR：100–120 下 / 分，約 5–6 cm、完全回彈；30:2，每口約 1 秒看胸起。呼吸脈搏檢查□10 秒。有脈搏呼吸不足每 6 秒一口。

教材成人正常值：呼吸 12–20 / 分、脈搏 60–100 / 分、SpO□ 約 94–100%。氧氣依缺氧及通氣調整；不要用觸摸哪條動脈就推算精確血壓。

教材危急線索：GCS<14、RR□30 或<10、HR>150 或<50、SBP>220 或<90、CRT>2 秒、體溫>41 或<32°C、SpO□<90%。任何嚴重表現也可危急，不能等數字全部達標。

八大徵象：意識、呼吸、脈搏、血壓、瞳孔、體溫、膚色、血氧。GCS E4 V5 M6，共 3–15 分。

病史：主之前吃過藥敏感。現病史 OPQRST。通報：病人要史已前到。教材重評：危急 5 分鐘、非危急 15 分鐘，變化隨時重評。

教材氧氣流量：鼻導管 1–6 L/min、簡單面罩 6–10、非再呼吸型面罩 10–15、BVM 10–15（課堂常開 15）。NRM 先充袋、吸氣時不應完全塌陷。

OHCA 評分表要怎麼讀

你提供的表：總分 25 分、19 分通過，18 以下不通過。第 1–4、10–12 項一般為不標準扣 1、錯誤扣 2；病史項另 1 分。

第 5–9 為 BLS 核心：AED、按壓位置、頻率、深度、胸回彈，採綜合加權；不標準扣 6、錯誤扣 10，2 項以上不標準以錯誤計。

頻率：100–120 標準；90–99 或 121–130 不標準；其餘錯誤。深度 / 回彈：QCPR 達標率 90–100% 標準，75–89% 不標準，<75% 錯誤。

網站只判定流程與螢幕按壓節奏。深度、回彈、實際按壓位置和 BVM 胸起須用假人 / QCPR 實測；可以在考官欄輸入真實讀值，未填不判「正式通過」。

整體技術測驗依投影片：平時 50、OHCA 25、情境 25，總分□76；OHCA 與情境各□19。其他情境沒有正式評分表，本網站的練習分數不冒充官方扣分。

OHCA 逐段演練

流程	主手	副手
開始	安全、防護、求援；確認反應；呼吸道、呼吸與脈搏	備 BVM、氧氣與 AED，回報就位
無脈搏	立即高品質按壓，30:2	開 AED、貼片接線；需要分析才喊清場
AED 分析	依指示暫停接觸，準備立即恢復 CPR	清場、分析；建議電擊才按，電擊後立即 CPR
持續急救	持續按壓、約 2 分鐘換手，減少中斷	OPA、BVM 密合；每 30 下配 2 口，約 1 秒看胸起
後續不電擊	依課程表快速查脈搏；無脈立即 CPR	有脈搏後協助評呼吸；不足則人工呼吸
恢復循環	維持 ABC、持續重評與後送	通報、病史、監測，支援照護

教材差異：這幾處要特別知道

低血糖：照片有無意識時塗糖牙齦 / 舌下的描述；新版指引要求無反應或無法安全吞嚥者不得口服糖。本網站依安全吞嚥條件執行，課堂考核口令須再和教官核對。

開放胸傷：照片寫三邊貼法；新版急救指引重視非密閉 / 專用可排氣胸封及重評。敷料後呼吸惡化須鬆開 / 移除並重評，不把貼好當作解除氣胸。

藥物：依臺灣現行規範，EMT-1 不直接協助吸入支氣管擴張劑、腎上腺素注射筆或 NTG；這些列在 EMT-2。模擬採詢問自備藥與回報進階救護。

中風：教材寫 3 小時，不可理解成超時就不用急送。最後正常時間、血糖、神經異常、適當醫院及急速後送仍重要。

這是數位流程練習。不是主辦單位完整考規重製，也不能保證通過；現場技術必須由教官及假人評核。情境內的惡化秒數是教學設定，不是臨床倒數。

01 | 過敏 / 嚴重過敏

非創傷 / 老師指定情境

餐廳，一名 28 歲女性吃完餐點後全身不舒服。

主副手分工

主手	副手
辨識呼吸道與循環危急，優先 ABC 支持、請求支援和後送。	給氧、量測、詢問過敏與用藥史，協助轉運。

共同起手式：安全、防護、求援；意識與 ABC / XABCDE。發現威脅立即處理，危急後送準備並行。

本題必抓的重點

1. 皮疹合併呼吸道或循環異常，就要當危急。

2. 避免讓低血壓患者突然站起。

3. EMT-1 不自行施打腎上腺素，請求進階救護。

專屬操作與口述

【胸部起伏、肺音與呼吸作功】看對稱性、說話能力、呼吸深淺與輔助肌。；聽診比較兩側，按教材右上、左上、左下、右下。

口述：我會檢查您的胸部與呼吸。

【接氧氣裝置、設定流量】開、看壓力、接、開流量、測氣、戴裝置。；依血氧、呼吸作功與通氣選擇，隨時重評。；呼吸不足時氧氣面罩不能取代 BVM。

口述：氧氣已接妥，確認流量及氣體流出。

【詢問病史：主之前吃過藥敏感】主訴、之前在做什麼、最後進食、過去病史、藥物、過敏、其他感受。；無法回答就向目擊者或家屬詢問；不延誤救命處置。

口述：哪裡不舒服？之前做什麼？吃過什麼？病史、用藥、過敏？

【辨識危急、請求進階支援】明確說出危急原因，119 / 進階救護支援。；快速後送準備可與處置、量測並行。

口述：此為危急患者，請求進階支援並準備快速後送。

最容易失分 / 造成風險

- 只看皮疹而漏掉休克。
- 讓藥物詢問延誤支援與後送。

收尾：處置後重評、記錄時間與數值、病史、通報及適當後送。病況改變立即回 ABC。

02｜氣喘 / 呼吸困難

非創傷 / 老師指定情境

運動場，一名 22 歲男性喘得很厲害。

主副手分工

主手	副手
評估呼吸作功、說話、肺音、意識，辨識通氣不足。	準備適當氧氣裝置、BVM、量測與後送。

共同起手式：安全、防護、求援；意識與 ABC / XABCDE。發現威脅立即處理，危急後送準備並行。

本題必抓的重點

1. 舒服坐姿、適當給氧、盡速支援。

2. 有脈搏但呼吸不足：BVM 每 6 秒一口，不做胸外按壓。

3. 喘鳴消失不一定代表改善。

專屬操作與口述

【胸部起伏、肺音與呼吸作功】看對稱性、說話能力、呼吸深淺與輔助肌。；聽診比較兩側，按教材右上、左上、左下、右下。

口述：我會檢查您的胸部與呼吸。

【接氧氣裝置、設定流量】開、看壓力、接、開流量、測氣、戴裝置。；依血氧、呼吸作功與通氣選擇，隨時重評。；呼吸不足時氧氣面罩不能取代 BVM。

口述：氧氣已接妥，確認流量及氣體流出。

【調整舒適姿勢】喘且循環允許時採舒適坐姿。；低血壓避免突然站立；創傷兼顧減移。

口述：協助您維持舒服、安全的姿勢。

【詢問病史：主之前吃過藥敏感】主訴、之前在做什麼、最後進食、過去病史、藥物、過敏、其他感受。；無法回答就向目擊者或家屬詢問；不延誤救命處置。

口述：哪裡不舒服？之前做什麼？吃過什麼？病史、用藥、過敏？

【辨識危急、請求進階支援】明確說出危急原因，119 / 進階救護支援。；快速後送準備可與處置、量測並行。

口述：此為危急患者，請求進階支援並準備快速後送。

最容易失分 / 造成風險

- 只有給氧，沒有重評通氣。
- 已無力呼吸時仍只戴面罩。

收尾：處置後重評、記錄時間與數值、病史、通報及適當後送。病況改變立即回 ABC。

03｜中風

非創傷 / 老師指定情境

家中，一名 67 歲女性突然說話不清楚。

主副手分工

主手	副手
G-FAST、辨識危急、查最後正常時間，送適當醫院。	測血糖、量測生命徵象、向家屬確認時間及病史。

共同起手式：安全、防護、求援；意識與 ABC / XABCDE。發現威脅立即處理，危急後送準備並行。

本題必抓的重點

1. G 眼球、F 臉、A 手、S 語言、T 最後正常時間。

2. 測血糖，排除可模仿中風的低血糖。

3. 超過某個時間窗仍須緊急評估後送。

專屬操作與口述

【執行 G-FAST 中風檢查】G：眼球追視。F：微笑看臉對稱。；A：雙手平舉。S：說一句完整話。；T：追問最後完全正常時間。

口述：請看我的手指、笑一下、雙手平舉，說一句話。

【血糖監測】確認試紙、洗淨乾燥 / 消毒待乾、指側採血。；讀值與記錄，針具回收。

口述：副手：測血糖。

【確認最後正常時間】問「最後一次看見他完全正常，是幾點？」；區分最後正常、發現異常及症狀開始時間。

口述：最後一次看到患者完全正常是幾點？

【詢問病史：主之前吃過藥敏感】主訴、之前在做什麼、最後進食、過去病史、藥物、過敏、其他感受。；無法回答就向目擊者或家屬詢問；不延誤救命處置。

口述：哪裡不舒服？之前做什麼？吃過什麼？病史、用藥、過敏？

最容易失分 / 造成風險

- 只問何時發現，沒問最後正常。
- 讓患者自行進食喝水。

收尾：處置後重評、記錄時間與數值、病史、通報及適當後送。病況改變立即回 ABC。

04｜胸痛

非創傷 / 老師指定情境

辦公室，一名 55 歲男性胸口不舒服。

主副手分工

主手	副手
OPQRST、危急辨識、安排心電圖與適當醫院。	量測、備 AED、12 導程貼片、通報與後送。

共同起手式：安全、防護、求援；意識與 ABC / XABCDE。發現威脅立即處理，危急後送準備並行。

本題必抓的重點

1. 記錄症狀與時間，持續重評，AED 隨時可用。

2. 按缺氧與呼吸狀況給氧，不因胸痛就一律最高濃度。

3. EMT-1 不直接給 NTG；詢問原處方與用藥史並回報。

專屬操作與口述

【詢問 OPQRST】發作方式、加重緩解、性質、位置轉移、程度、時間。

口述：何時開始、什麼感覺、哪裡痛、有沒有轉移、幾分痛？

【貼附十二導程心電圖】四肢電極依標示，V1 胸骨右緣第 4 肋間、V2 左緣第 4 肋間。；先放 V4 左鎖骨中線第 5 肋間，再放 V3 於 V2/V4 中間。；V5 腋前線、V6 腋中線，與 V4 同水平；記錄並回報。

口述：貼附十二導程，記錄並回報。

【詢問病史：主之前吃過藥敏感】主訴、之前在做什麼、最後進食、過去病史、藥物、過敏、其他感受。；無法回答就向目擊者或家屬詢問；不延誤救命處置。

口述：哪裡不舒服？之前做什麼？吃過什麼？病史、用藥、過敏？

【接氧氣裝置、設定流量】開、看壓力、接、開流量、測氣、戴裝置。；依血氧、呼吸作功與通氣選擇，隨時重評。；呼吸不足時氧氣面罩不能取代 BVM。

口述：氧氣已接妥，確認流量及氣體流出。

【辨識危急、請求進階支援】明確說出危急原因，119 / 進階救護支援。；快速後送準備可與處置、量測並行。

口述：此為危急患者，請求進階支援並準備快速後送。

最容易失分 / 造成風險

- 等胸痛自己消失。
- 低血壓仍鼓勵使用降壓藥。

收尾：處置後重評、記錄時間與數值、病史、通報及適當後送。病況改變立即回 ABC。

05｜低血糖

非創傷 / 老師指定情境

住家，一名 60 歲男性冒冷汗、回答奇怪。

主副手分工

主手	副手
維持 ABC、評意識與吞嚥，處置後重評。	測血糖、準備口服葡萄糖、詢問用藥與進食。

共同起手式：安全、防護、求援；意識與 ABC / XABCDE。發現威脅立即處理，危急後送準備並行。

本題必抓的重點

1. 先測血糖，再確認清醒且能安全吞嚥。

2. 口服葡萄糖後持續重評；指南常於 15 分鐘重測。

3. 無反應 / 不能吞嚥時，停止口服，顧 ABC、支援與後送。

專屬操作與口述

【血糖監測】確認試紙、洗淨乾燥 / 消毒待乾、指側採血。；讀值與記錄，針具回收。

口述：副手：測血糖。

【確認清醒與安全吞嚥】確認能依指令、自主保護呼吸道且能安全吞嚥。；不能安全吞嚥就停止口服。

口述：先確認您可以安全吞嚥。

【給口服葡萄糖】確認已測低血糖、清醒且能安全吞嚥。；依產品與受訓流程給成人約 15–20 g 葡萄糖，後續重評。

口述：能安全吞嚥，依流程給口服葡萄糖。

【處置後重測血糖】持續觀察反應，通常口服後約 15 分鐘重測。；持續異常、不能吞嚥或神經症狀未改善，請求支援後送。

口述：重測血糖並重新評估意識。

【詢問病史：主之前吃過藥敏感】主訴、之前在做什麼、最後進食、過去病史、藥物、過敏、其他感受。；無法回答就向目擊者或家屬詢問；不延誤救命處置。

口述：哪裡不舒服？之前做什麼？吃過什麼？病史、用藥、過敏？

最容易失分 / 造成風險

- 意識不清時把糖塗入口中或舌下。
- 只看血糖回升，沒有重評神經症狀。

收尾：處置後重評、記錄時間與數值、病史、通報及適當後送。病況改變立即回 ABC。

06｜安全帽脫除

創傷 / 老師指定情境

路口，一名 30 歲男性機車騎士倒地，戴著全罩安全帽。

主副手分工

主手	副手
統一口令、評估、與副手明確交接頸椎支撐。	持續減移、準備器材、確認接手再放開。

共同起手式：安全、防護、求援；意識與 ABC / XABCDE。發現威脅立即處理，危急後送準備並行。

本題必抓的重點

1. 固定自己、固定支點、固定患者。

2. 解扣、改用下顎 / 枕部支撐、脫帽、再接回固定。

3. 頸圈不等於取代持續適當減移；固定後重評。

專屬操作與口述

【手持頸椎減移 / 接手】固定自己與支點，維持適當對線。；若由隊友接手，先說「我接穩了」，原固定者確認後才放手。

口述：我已接穩頸椎，請保持不動。

【雙人脫安全帽】一人持續頭部減移，另一人解扣。；交接下顎及枕部支撐，得到「已接穩」才放手。；另一人緩慢脫帽，完成後接回頭部減移。

口述：我接穩了。好，開始脫帽。完成後接回固定。

【檢查頸部與頸椎】保持減移，檢查氣管、頸靜脈與壓痛。；詢問痛、痠、麻，不強迫活動頸部。

口述：有沒有頸部痠、痛或麻？

【量測、選擇與戴頸圈】先檢查頸部，量下巴至肩線、選適當尺寸。；有人持續減移，另一人戴頸圈。；戴好後重評；不能把頸圈視為免再保護。

口述：持續頸椎減移，我來戴頸圈。

【固定前：遠端 PSM】P 脈搏、S 感覺、M 運動。；記錄固定前狀態，露出末端便於重評。

口述：摸得到嗎？有感覺嗎？手指 / 腳趾動一下。

最容易失分 / 造成風險

- 同一人固定頭部又離手拿器材。
- 沒有收到「已接穩」就放手。

收尾：處置後重評、記錄時間與數值、病史、通報及適當後送。病況改變立即回 ABC。

07｜大出血

創傷 / 老師指定情境

工地，一名 42 歲男性右大腿大量出血。

主副手分工

主手	副手
在 X 立即控制致命出血，辨識休克與後送。	準備止血帶、記時間、量測，保暖與搬運。

共同起手式：安全、防護、求援；意識與 ABC / XABCDE。發現威脅立即處理，危急後送準備並行。

本題必抓的重點

1. 先止血，再繼續其餘評估；兩人可並行。

2. 直接加壓仍控制不了的肢體大出血，要早用止血帶。

3. 放在傷口近心端，避開關節，收緊至止血並記時間。

專屬操作與口述

【直接加壓 / 接手加壓】敷料覆蓋出血點，持續直接加壓。；未控制時保持加壓，指派另一人準備止血帶。

口述：持續加壓，請準備止血帶。

【放置止血帶並記時間】肢體致命出血，近心端、避開關節。；看得見傷口時約上方 5–7 cm，依器材受訓方式。；收緊至出血停止，記時間、不任意鬆開。

口述：止血帶已收緊，確認止血，記錄時間。

【重查止血效果】確認出血是否停止、止血帶是否有效。；仍出血需調整 / 追加受訓處置，不把包好等同止血。

口述：重新檢查是否仍有出血。

【保暖與防低體溫】覆蓋非檢查部位，隔絕濕冷與地面。；不妨礙傷口監測與後續處置。

口述：協助保暖。

最容易失分 / 造成風險

- 完成全套二度評估才止血。
- 任意定時鬆開止血帶。

收尾：處置後重評、記錄時間與數值、病史、通報及適當後送。病況改變立即回 ABC。

08｜斷肢

創傷 / 老師指定情境

工廠，一名 38 歲男性左前臂斷離。

主副手分工

主手	副手
先救患者、控制出血與休克，安排後送。	患者處置有人接續後，包裝斷肢、標示及隨人送醫。

共同起手式：安全、防護、求援；意識與 ABC / XABCDE。發現威脅立即處理，危急後送準備並行。

本題必抓的重點

1. 先顧患者，斷肢由副手處理。

2. 濕潤乾淨敷料包裹、密封袋、隔袋冷卻。

3. 記錄事件 / 止血帶時間，斷肢隨患者送醫。

專屬操作與口述

【直接加壓 / 接手加壓】敷料覆蓋出血點，持續直接加壓。；未控制時保持加壓，指派另一人準備止血帶。

口述：持續加壓，請準備止血帶。

【放置止血帶並記時間】肢體致命出血，近心端、避開關節。；看得見傷口時約上方 5–7 cm，依器材受訓方式。；收緊至出血停止，記時間、不任意鬆開。

口述：止血帶已收緊，確認止血，記錄時間。

【重查止血效果】確認出血是否停止、止血帶是否有效。；仍出血需調整 / 追加受訓處置，不把包好等同止血。

口述：重新檢查是否仍有出血。

【包裝、標示、冷卻斷肢】濕潤乾淨敷料包裹，放密封袋。；隔袋冷卻，不直接泡水 / 接觸冰 / 冷凍。；標示患者與時間，隨患者送醫。

口述：斷肢已妥善包裝，隨患者送醫。

【保暖與防低體溫】覆蓋非檢查部位，隔絕濕冷與地面。；不妨礙傷口監測與後續處置。

口述：協助保暖。

最容易失分 / 造成風險

- 斷肢直接接觸冰、浸水或冷凍。
- 忙著找斷肢卻放著患者流血。

收尾：處置後重評、記錄時間與數值、病史、通報及適當後送。病況改變立即回 ABC。

09｜骨折

創傷 / 老師指定情境

樓梯旁，一名 45 歲女性跌倒後右小腿變形。

主副手分工

主手	副手
檢查其他傷害，固定前後評估遠端神經血管。	支撐患肢、備護墊與夾板、配合固定及搬運。

共同起手式：安全、防護、求援；意識與 ABC / XABCDE。發現威脅立即處理，危急後送準備並行。

本題必抓的重點

1. P 脈搏、S 感覺、M 運動，固定前後都做。

2. 以原姿勢支撐固定，跨骨折上下關節。

3. 固定後疼痛、脈搏、皮色與感覺變差要重評。

專屬操作與口述

【固定前：遠端 PSM】P 脈搏、S 感覺、M 運動。；記錄固定前狀態，露出末端便於重評。

口述：摸得到嗎？有感覺嗎？手指 / 腳趾動一下。

【支撐、護墊與夾板固定】先做遠端 PSM，維持原姿勢並支撐。；護墊、跨上下關節固定，露出末端。；完成後重查 PSM。

口述：先支撐患肢，固定後再查 PSM。

【固定後：重查遠端 PSM】與固定前比較脈搏、感覺、運動、膚色與疼痛。；惡化就重新評估固定與循環。

口述：固定後再檢查末端脈搏、感覺和運動。

最容易失分 / 造成風險

- 例行把變形部位拉直。

- 只包紮卻沒評遠端循環。

收尾：處置後重評、記錄時間與數值、病史、通報及適當後送。病況改變立即回 ABC。

10｜燒傷

創傷 / 老師指定情境

住家廚房，一名 36 歲女性被熱湯燙傷右前臂。

主副手分工

主手	副手
確認安全、停止灼傷、查吸入傷與燒傷範圍。	局部適當冷卻、乾淨覆蓋、保暖與後送。

共同起手式：安全、防護、求援；意識與 ABC / XABCDE。發現威脅立即處理，危急後送準備並行。

本題必抓的重點

1. 局部熱燙傷用流動涼水冷卻，目標約 20 分鐘；後送可同步。

2. 不撕黏住的衣物，不用冰塊、不挑破水泡。

3. 大面積 / 吸入傷等危急者，避免低體溫，優先 ABC 與後送。

專屬操作與口述

【燒傷範圍 / 吸入傷評估】看部位、深度、範圍、時間與機轉。；查臉頸燒傷、煙灰、聲音沙啞、密閉空間暴露。

口述：檢查燒傷範圍與有沒有吸入傷。

【開始局部流動涼水冷卻】先停止熱源，移除未黏住的衣物 / 飾物。；局部適當冷卻，目標約 20 分鐘，可與後送同步。；大範圍 / 危急者優先 ABC、防低體溫。

口述：局部涼水冷卻，注意其他部位保暖。

【停止冷卻、乾淨覆蓋傷口】適當冷卻後，用乾淨敷料鬆覆。；不用冰、牙膏或藥膏，不挑破水泡。

口述：乾淨覆蓋傷口。

【保暖與防低體溫】覆蓋非檢查部位，隔絕濕冷與地面。；不妨礙傷口監測與後續處置。

口述：協助保暖。

最容易失分 / 造成風險

- 所有燒傷一律長時間全身沖冷水。
- 塗藥膏、牙膏或直接冰敷。

收尾：處置後重評、記錄時間與數值、病史、通報及適當後送。病況改變立即回 ABC。

11 | 氣胸 / 穿刺傷

創傷 / 老師指定情境

工地，一名 40 歲男性胸部被尖銳物刺傷後喘。

主副手分工

主手	副手
查胸傷、肺音與循環，辨識危急、快速後送。	給氧、敷料 / 異物固定、反覆重評，準備 BVM。

共同起手式：安全、防護、求援；意識與 ABC / XABCDE。發現威脅立即處理，危急後送準備並行。

本題必抓的重點

1. 專用可排氣胸封，或非密閉乾淨敷料，處理後反覆觀察。

2. 貼敷料後呼吸惡化，要評估移除 / 鬆開並重評。

3. 有異物不拔出；EMT-1 不做針刺減壓。

專屬操作與口述

【暴露、快速創傷檢查】兼顧隱私與保暖，找致命傷、胸部開放傷、異物。；創傷 XABCDE，危險發現即處置。

口述：我需要檢查傷口，會注意保暖。

【胸部起伏、肺音與呼吸作功】看對稱性、說話能力、呼吸深淺與輔助肌。；聽診比較兩側，按教材右上、左上、左下、右下。

口述：我會檢查您的胸部與呼吸。

【接氧氣裝置、設定流量】開、看壓力、接、開流量、測氣、戴裝置。；依血氧、呼吸作功與通氣選擇，隨時重評。；呼吸不足時氧氣面罩不能取代 BVM。

口述：氧氣已接妥，確認流量及氣體流出。

【處理開放胸傷】依受訓器材使用可排氣胸封，或非密閉乾淨敷料。；不可視為做完就沒事，反覆重評呼吸。；呼吸惡化時鬆開 / 移除敷料並重評，請求進階支援。

口述：處理胸部傷口，持續觀察呼吸變化。

【辨識危急、請求進階支援】明確說出危急原因，119 / 進階救護支援。；快速後送準備可與處置、量測並行。

口述：此為危急患者，請求進階支援並準備快速後送。

最容易失分 / 造成風險

- 把貼三邊當成處理完成，後續不重評。
- 拔出異物或自行針刺胸部。

收尾：處置後重評、記錄時間與數值、病史、通報及適當後送。病況改變立即回 ABC。

其他 T1 單位怎麼考？

以下是公開簡章的比較，不取代你這班規則。各機構配分不同，不能取較低的及格門檻套用。

旺英基金會

學科、術科各需 76 分，各一次即時補考。照片上技術細分為平時 50、OHCA 25、情境 25。

官方資料連結

門諾醫院 2026

筆試 40 題×2，滿分 80 且要求 80 / 80；未滿分提示修正再答。術科未過需回覆示教、修正再考，兩次修正後仍未過則不合格。

官方資料連結

北護大 115 年

學科、術科分別至少 70 分，各一次補考；課程含半情境及全情境。

官方資料連結

臺中紅十字會 115 年

學科、術科各達 70 分，各一次補考。

官方資料連結

內政部替代役訓練 FAQ

筆試 40%、實作 60%；實作分 CPR（含 AED）與止血包紮。

官方資料連結

最嚴格的練習方式

第一輪帶練，主副手輪換；第二輪無提示抽題；每次先修正重大風險，再補漏項。從錯誤前狀態重新操作到正確，不只看分數。真實器材練習另由教官確認。

網站自訂重大風險檢核

無反應口服糖、未清場分析 / 電擊、未交接放開固定、漏認 OHCA、持續大出血卻先做不必要檢查等，標記「需重練」。這是加嚴學習門檻，並非宣稱各機構均一項即不及格。

資料來源與版本

課程照片

你提供的第 30–31、39–44、46–53、58–65、68–75 頁，手寫情境清單及 OHCA 評分表；未上傳照片與個人資料。

臺灣 EMT 執業範圍

救護技術員管理辦法第 13、14 條；本模擬鎖定 EMT-1。

https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCODE=L0020141

消防署單項技術

2025 救護技術操作指引：BVM、頸椎減移、脫帽、止血與骨折固定。

https://ebook.nfa.gov.tw/1140526/files/basic-html/index.html

消防署救護教材

2025 緊急救護教材：中風、創傷、燒傷等。

https://ebook.nfa.gov.tw/1140527/files/basic-html/index.html

AHA 2025 成人 BLS

呼吸 / 脈搏評估、CPR、AED、呼吸停止與恢復循環的分支。

https://cpr.heart.org/-/media/CPR-Files/CPR-Guidelines-Files/2025-Algorithms/Algorithm-BLS-Adult-Healthcare-250701.pdf

AHA 2024 急救

開放性胸傷、止血與其他急救處置。

https://cpr.heart.org/en/resuscitation-science/2024-first-aid-guidelines

RCUK 2025 急救

低血糖吞嚥條件、危急辨識、出血及胸傷敷料重評。採臺灣 119 與 EMT-1 範圍。

https://www.resus.org.uk/professional-library/2025-resuscitation-guidelines/first-aid-guidelines

你的三步練習計畫

每天 30 分鐘：OHCA 15 分鐘，主副手各做一遍；情境抽兩題 10 分鐘，邊講邊做；最後 5 分鐘對照紀錄找出漏項。每次把「什麼時候跳流程」說清楚。

考前必問教官

正式情境評分表與時限；主副手固定分工與可互換項目；OPA / BVM / AED 判定標準；低血糖口服與開放胸傷的課程口令如何與新指引銜接。